

4 合併症とその対策

本邦の2016年気管支鏡全国調査によると、EBUS-TBNAによる合併症については出血(0.40%)、肺炎・胸膜炎(0.16%)、喘息(0.16%)、喘息(0.05%)、気胸(0.04%)などが認められた²⁴⁾。一方で、頻度は低いものの縦隔炎などの重症感染症をきたすことがある。

文 献

- 1) 日本肺癌学会(編): 気管支鏡診断, 臨床・病理 肺癌取扱い規約, 第9版, 金原出版, p182, 2025
- 2) 於保健吉ほか: 気管支ファイバースコープ—その手技と所見の解析・気管支ビデオスコープとその解説, 第6版, 医学書院, p53, 1994
- 3) 清嶋護之: 気管支鏡所見の取り方, 分類, 気管支鏡ベストテクニック改訂3版, 浅野文祐ほか(編), 中外医学社, p35-36, 2024
- 4) 清嶋護之ほか: 気管支学 **40**: 402, 2018
- 5) 雨宮隆太ほか: 気管支学 **33**: 75, 2011
- 6) 日本呼吸器内視鏡学会安全対策委員会(編): 手引書—呼吸器内視鏡診療を安全に行うために—(ver. 5.0), 2024 (http://www.jsre.org/medical/anzen_tebiki_4.pdf) (2025年1月24日閲覧)
- 7) Rivera MP, et al: Chest **143** (5 Suppl): e142S, 2013
- 8) Hunninghake GW, et al: Am J Respir Crit Care Med **160**: 736, 1999
- 9) Shorr AF, et al: Chest **120**: 109, 2001
- 10) Du Rand IA, et al: Thorax **68** (1 Suppl): i1, 2013
- 11) Asano F, et al: Respirology **17**: 478, 2012
- 12) 品川尚文: 検体採取方法と処理方法, 気管支鏡テキスト(第3版), 日本呼吸器内視鏡学会(編), 医学書院, p155-166, 2019
- 13) 品川尚文: 検体採取, 処理方法, 気管支鏡ベストテクニック改訂3版, 浅野文祐ほか(編), 中外医学社, p54-81, 2024
- 14) Asano F, et al: Respiration **88**: 430, 2014
- 15) Miyake K, et al: JBIP **25**: 305, 2018
- 16) Kurimoto N, et al: Chest **126**: 959, 2004
- 17) 品川尚文: 検体採取方法と処理方法, 気管支鏡テキスト(第3版), 日本呼吸器内視鏡学会(編), 医学書院, p155-166, 2019
- 18) 日本呼吸器学会びまん性肺疾患学術部会厚生労働省難治性疾患克服研究事業びまん性肺疾患調査研究班: 気管支肺胞洗浄(BAL)法の手引き, 改訂第3版, 克誠堂出版, 2017
- 19) 日本呼吸器学会びまん性肺疾患診断・治療ガイドライン作成委員会(編): 特発性間質性肺炎診断と治療の手引 2022 (改訂第4版), 南江堂, 2022
- 20) Nakano H: Tohoku J Exp Med **174**: 379, 1994
- 21) Yasufuku K, et al: J Thorac Cardiovasc Surg **142**: 1393, 2011
- 22) Nakajima T, et al: Gen Thorac Cardiovasc Surg **61**: 390, 2013
- 23) 日本肺癌学会(編): 肺癌診療ガイドライン 2025年版—悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍を含む
- 24) Horinouchi F, et al: JBIP **27**(34): 253, 2020